

张建来 mPDAC MDT 病史汇报 2026-07-16

张建来 晚期胰腺导管腺癌 MDT 病史汇报

汇报日期：2026-07-16 汇报目的：提交多学科会诊（MDT）

一、患者基本信息

项目	内容
姓名	张建来
性别	男
出生日期	1958-05-04（68 岁）
身份证号	340504195805040039
民族	汉族
籍贯	安徽省（久居北京）
职业	退休（原北京瑞尔非金属材料有限公司）
永久地址	北京市海淀区小营西路橡树湾五期万象府 8 号楼 2 单元 401
紧急联系人	张成毅（子），18600058581
当前住院	北京中关村医院 肿瘤病区（2026-06-23 起）

二、主诊断与分期

主诊断：胰腺中低分化导管腺癌（PDAC），胰头钩突占位，IV 期（cT3N1M1，肝多发转移）

病理确诊：2026-04-07 EUS-FNA 穿刺活检（北医三院） **首发症状时间：**2026 年 3 月中下旬皮肤巩膜黄染

分期依据：2026-06-14 中国医学科学院肿瘤医院上腹 MR 动态增强+DWI 明确肝多发转移瘤 **可切除性：**不可手术（SMV 受压+可疑 SMA 侵犯+肝多发转移）

三、既往史与合并症

3.1 既往合并症（2026-04-03 北医三院入院志记载）

慢病	病史	长期用药
高血压病 3 级	20 余年（最高 180 mmHg）	缬沙坦 80 mg QD + 氨氯地平 5 mg QD
高血压性脑出血	8 年（2018 年），保守治疗后好转	—
陈旧性脑梗死	3 年（2023 年），遗留双下肢无力	—
帕金森综合征	数年	雷沙吉兰 1 mg QD + 金刚烷胺 0.1 g BID + 甲钴胺 0.5 mg QD + 多巴丝肼 0.125 g-0.5 g-0.5 g TID
高脂血症	数年	阿托伐他汀 20 mg QN
脑卒中二级预防	—	西洛他唑 50 mg BID（抗血小板）

3.2 既往手术史

- **本次胰腺癌之前无任何大手术史**（2026-06-28 家属复核）
- 本次相关手术：
 - 2026-04-07 EUS-FNA 胰腺穿刺活检（北医三院）
 - 2026-04-10 ERCP + DSA 胆道**塑料**支架置入术（北医三院）
 - 2026-06-22 内镜下经鼻三腔营养管置入术（北医三院普外急诊，因胃潴留+十二指肠恶性狭窄）
 - **2026-07-02 十二指肠 SEMS 金属自膨胀支架置入术（北医三院；同期撤除三腔营养管，恢复口服）**

3.3 过敏史

无药物、食物、造影剂过敏史（2026-06-28 家属复核）

3.4 个人史

- 生于安徽，久居北京
- **不吸烟、不饮酒**（入院志与家属双重确认）
- 无疫区/疫水、无化学放射性接触史、无吸毒史

3.5 家族史

否认家族性遗传病史与肿瘤家族史。综合”不吸烟+不饮酒+无家族肿瘤史”及基因检测（KRAS G12D + CDKN2A + Smad4 缺失）→ 提示**散发性体细胞驱动突变型 PDAC**，非遗传性。

四、诊疗时间线（关键节点）

日期	医院	关键事件
2026-02 末 / 03 初	—	出现皮肤巩膜黄染（首发症状）
2026-03-30	北京协和急诊	基线全套：CA19-9 2203 、TBIL 162.3、ALT 214、CRP 23.76、AMY 184；胸部 CT 示胆总管下段团块
2026-04-01	北京协和（国际医疗肝胆外科）	首诊：胰腺恶性肿瘤 + 梗阻性黄疸
2026-04-02	北京协和（特需基本外科）	制定”新辅助化疗 + 胆道引流”方案
2026-04-03	北医三院普外二病房（住院号 5047176）	入院；MRCP：胰头肿块 45 mm，双管征
2026-04-04	北医三院	腹盆腔 CT 增强：胰头 45 mm，与门静脉关系密切；消化系统彩超：胰头钩突 7.1×4.1×3.6 cm 、SMV 受压、CBD 2.3 cm 极度扩张、肝囊肿 1.5 cm、胆囊息肉 0.3 cm、 肝脏未见转移瘤 ；双下肢静脉： 无血栓（VTE 基线） ；颈动脉：双侧粥样斑块（0-49% 轻度狭窄）
2026-04-07	北医三院	EUS-FNA 穿刺活检 → 病理： 胰腺中低分化腺癌 ；超声造影示典型 PDAC 乏血供表现
2026-04-10	北医三院	ERCP + DSA 胆道塑料支架置入术 （张铃福医生）
2026-04-14	北医三院	出院；出院带药：耐信 20 mg BID + 易善复 456 mg TID + 天晴甘平 150 mg TID + 迪先 10 ml BID
2026-04-16 / 04-22	北医三院	病理免疫组化补充：MMR pMMR、HER2 1+、PD-L1 CPS<1、Smad4 缺失
2026-04-27	北医三院	NGS 报告： KRAS G12D、TP53 V274D、CDKN2A 缺失、ARID1A、MTAP 缺失、Claudin18.2 3+ 60%
2026-05-09	中国医学科学院肿瘤医院	化疗前真正基线 CT 增强（胸+全腹+盆腔+薄层） ：胰头 4.2×3.8 cm，侵犯十二指肠降+水平段、SMV、可疑 SMA； 肝多发转移瘤可能（最大 1.2×1.1 cm） ；淋巴结 0.9 cm；腹+盆腔少量积液+腹膜稍厚；双肺结节 0.8×0.5 cm；双肾囊肿 → 实际确诊即 IV 期 mPDAC （05-12 出院时报告为 T3N0M0 II 期系初步低估）
2026-05-11	肿瘤医院	C1D1 AG 化疗 ：白蛋白紫杉醇 190 mg + 吉西他滨 1.6 g
2026-05-13	清华长庚	苏日嘎教授（肝胆肿瘤科）咨询意见
2026-05-25	肿瘤医院	C2D1（方案改为 14 天周期）

日期	医院	关键事件
2026-06-08	肿瘤医院	C3D1
2026-06-13	肿瘤医院	CT 增强疗效评估：胰头 4.2×3.8 cm 稳定；肝结节部分较前缩小；淋巴结 0.9→0.7 cm → AG 有效
2026-06-14	肿瘤医院	上腹 MR 动态增强+DWI： 明确肝多发转移瘤 (1.2×1.0 cm) → 分期 II 上调 IV (mPDAC)
2026-06-18	肿瘤医院 C3D10	☑ 化验补录发现”胆管炎 3 天前驱期”完整证据链 ：血常规 24 项 (MONO% 11.2 ↑ 唯一非贫血异常, EO# 0.05 临界低) + 生化 19 项 (ALP 140.9 ↑ 1.13×、DBIL 4.9 ↑ 1.23× 双升胆道支架亚临床炎症；ALT 33.8 ☑、AST 26.7 ☑、TBIL 14.5 ☑ 全正常) + 肿瘤标志物 5 项 (CA19-9 402 / CA242 77.6 , 均较 5/9 上升, 含胆道支架炎症干扰) + 凝血 10 项 (D-Dimer 1.27 ↑ 首次高凝证据 , FDP 3.54 ☑ AT-III 94.1 ☑)
2026-06-21	急诊	☑ 反酸呕吐 24 h + 发热 39.2 °C + WBC 13.15/NEUT% 91.1%/CRP 69 + ALT 632/AST 520/ALP 540/GGT 608/TBIL 39.7 → 急性胆管炎 Grade II (胆道塑料支架相关) + 恶性十二指肠梗阻
2026-06-22	北医三院	美罗培南 15 h 有效 (PCT 2.91→1.88, AST 520→238)； 内镜下经鼻三腔营养管置入 (诊断：十二指肠降部恶性狭窄, 建议必要时行 SEMS 或 EUS-GE)
2026-06-23	中关村医院肿瘤病区	转入住院 ；启动双轨营养 TPF 60 ml/h 鼻饲 + PN 约 650 kcal/d；抗生素降阶梯为头孢他啶 + 美洛西林 + 左奥硝唑三联；保肝 (谷胱甘肽 + 硫普罗宁)； 肿瘤标志物复查：CA19-9 362、CA242 37.2 (-52% vs 6/18, ☑CA19-9/CA242 解偶联)； 中关村凝血 10 项 ：D-Dimer 1.091 ↑、FDP 8.11 ↑、FIB 425 ↑、AT:A 80 ↓ → 完整高凝四联登场 (vs 6/18 仅单项高凝)
2026-06-25	中关村医院肿瘤病区	甲状腺自身抗体：TGAbs 312 ↑ + TPOAb 72.2 ↑ → 桥本氏甲状腺炎 (新发现)；PCT 0.767；IL-6 23；呼吸道病原体 5 项 IgM 全阴
2026-07-02	北医三院	十二指肠 SEMS 置入术 (BOSTON 6502 WallFlex 27/22×9 + Jagwire 导丝, 医保 23,199 元)；同日上午北京高博医院周军主任二线咨询门诊； 当天中关村凝血 10 项 ：D-Dimer 0.468 (-57% vs 6/23)、FDP 3.64 (-55%)、FIB 357 ☑ → 高凝四联 3/4 项 9 天内回落, 仅

日期	医院	关键事件
		AT:A 76 继续降 → 感染源控制 = 最有效抗凝措施
2026-07-03	中关村医院肿瘤病区	血液学全面恢复: WBC 5.42/NEUT 3.79/PLT 272/HGB 90↑; PCT 0.135 ☒ 感染最低点; IL-6 11.63; 肝功能爆炸性恢复: ALT 25.5 (-96%) 、 AST 23.4 (-96%) 、 TBIL 7.8 (-80%) 全正常; 仅 GGT 227.7↑
2026-07-12	中关村医院肿瘤病区	☒ 全套化验三系反弹 (详见”当前问题”), 血常规 24 项 + 生化 19 项 + 免疫 2 项完整补录

五、关键影像学总结

检查	日期	医院	关键发现
胸部 CT 平扫	2026-03-30	协和急诊	胆总管下段团块, 双肺微小结节
MRCP	2026-04-03	北医三院	胰头肿块 45 mm, 双管征
腹盆腔 CT 增强	2026-04-04	北医三院	胰头 45 mm, 与门静脉关系密切
消化系统彩超	2026-04-04	北医三院	胰头钩突 7.1×4.1×3.6 cm + SMV 受压 + CBD 2.3 cm 扩张 + 肝脏未见转移
超声造影 (穿刺同期)	2026-04-07	北医三院	典型 PDAC 乏血供廓清早于胰腺组织
化疗前基线 CT 增强 +薄层	2026-05-09	肿瘤医院	胰头 4.2×3.8 cm; 侵犯十二指肠降 + 水平段 + SMV + 可疑 SMA; 肝多发转移瘤可能 (1.2×1.1 cm) ; 淋巴结 0.9 cm; 腹+盆腔积液; 双肺结节; 双肾囊肿
AG 疗效评估 CT 增强	2026-06-13	肿瘤医院	胰头 4.2×3.8 cm 稳定; 肝结节部分较前缩小; 淋巴结 0.9→0.7 cm; AG 有效
上腹 MR 动态增强 +DWI	2026-06-14	肿瘤医院	胰头 4.9×3.8 cm; 肝多发 DWI 高信号结节 1.2×1.0 cm → 明确诊断”肝多发转移瘤” (分期升至 IV)

六、分子病理与基因检测（NGS 2026-04-27）

检测	结果	临床意义
KRAS	G12D (c.35G>A, VAF 26.94%)	驱动突变；G12D 特异性抑制剂在研（HRS-4642 / Zoldonrasib / GFH375 / INCB161734）
TP53	V274D (c.821T>A, 37.12%)	抑癌基因失活；WEE1 抑制剂潜在靶点
CDKN2A	拷贝数缺失（CN=1.16）	细胞周期失调
ARID1A	D2178Gfs*47 (24.19%)	功能丧失
MTAP	杂合缺失（9p21.3）	MAT2A 抑制剂靶点（在研）
RNF43	A46S	Wnt 通路，意义不明
BIRC3	BIRC3-METTL25B 融合（15.43%）	意义不明
MSI	MSS	免疫单药无效
TMB	4.1 突变/Mb（低）	免疫单药无效
PD-L1	阴性（CPS<1, SP263）	免疫单药无效
Smad4/DPC4	表达缺失	预后不良，倾向远处转移；提示吉西他滨方案更适合
HER2	1+（低表达）	传统 HER2 靶向药不适；T-DXd 潜在二线备选
MMR	pMMR（四项正常）	与 MSS 一致
Claudin 18.2	阳性（60%， 3+）	符合 CLDN18.2 靶向治疗标准（Zolbetuximab、CLDN18.2 ADC、CT041 CAR-T）
BRCA1/2	无突变	PARP 抑制剂不适

核心可干预靶点：
KRAS G12D（一级）+ Claudin 18.2 3+ 60%（一级）+ TP53/CDKN2A/MTAP（研究级）

七、关键指标趋势

7.1 CA19-9 与 CA242（肿瘤标志物解偶联 ☒）

日期	CA19-9	CA242	说明
2026-03-30	2203 ☒	125.8 ☒	基线（重度黄疸）
2026-05-09	255	52.9	↓ 88% / ↓ 58%（主因 ERCP 引流）
2026-06-18	402 ↑	77.6 ↑	C3D10: CA19-9 +58% / CA242 +47%（含胆道支架亚临床炎症干扰）
2026-06-23	362 ↑	37.2 ☒	胆管炎爆发 D2; ☒ CA242 从 6/18 骤降 52%，vs 5/9 净降 30% ☒
2026-06-24	362	37.2	同批次报告

☒☒☒ 核心洞察：CA19-9 与 CA242 解偶联 - CA19-9 5/9 → 6/23: ↑ 42%（受胆道支架炎症干扰） - CA242 5/9 → 6/23: ↓ 30%（真实肿瘤生化应答） - → AG 方案可能仍有生化效果，之前”生化 PD”判断需修正为”混合应答（审慎乐观）” - MDT 建议：炎症完全消退（PCT 正常 ≥ 2 周）后复查 CA19-9+CA242，判定真实肿瘤应答

7.2 TBIL（总胆红素）

2026-03-30: 162.3 → 05-09: 53.8 (-67%) → 05-19: 29.9 (-82%) → 07-03: 7.8 ☒ → 07-12: 7.3 ☒（仍正常）

关键：7/12 ALT/GGT 反弹但 TBIL 未升 → 胆道支架未完全堵塞，处于早期干预窗

7.3 化疗骨髓抑制轨迹

时点	WBC	NEUT	HGB	PLT	备注
5/9 化疗前	5.06	—	100	215	基线
5/16 C1D5	3.42 ↓	2.01	96	216	
5/28 C1D17	3.54	2.21	82 ↓ ↓	333	
5/31 C2D6	2.63 ↓ ↓	1.18 ↓ ↓	85	321	II 度粒减 + WBC 减
6/3 C2D9	3.68	1.82	81	225	
6/18 C3D10	3.96 ☒	2.12 ☒	97 ↑	220 ☒	☒ 胆管炎前基线： 骨髓已充分恢复 (HGB 回升 20%)
7/3 C3D25 (SEMS 后 D1)	5.42 ☒	3.79 ☒	90	272	全面恢复
7/12 C3D34	5.53 ☒	4.06 ☒	87 ↓	111 ↓ ↓	☒ PLT 大幅下降 (消耗型，非骨髓抑制型)

7.4 感染监测轨迹（PCT / IL-6）

日期	PCT	IL-6	事件
6/21	2.91 ☒☒☒	—	☒ 急性胆管炎爆发
6/22	1.88	—	美罗培南 15 h -35%
6/25 (=6/24 采样)	0.767	23	抗生素降阶梯
7/3	0.135 ☒	11.63	最低点
7/9	0.396 ↑	23.64 ↑	SEMS 术后 D7 早期反弹
7/12	0.522 ↑ ↑	16.97 ↑	△ 反弹 4 倍，胆道感染再激活

7.5 【新增】高凝状态三阶段演变（凝血四联）

时点	D-Dimer	FDP	FIB	AT:A	阶段	备注
4/4 基线	—	—	—	—	干净	双下肢静脉超声无血栓
6/18 (C3D10)	1.27 ↑	3.54 ☒	369	94.1 ☒	Phase 1: 慢性高凝	☒ 仅 D-Dimer 孤立升高 (CAT 模式: 肿瘤+化疗+卧床+多导管), 无炎症干扰
6/23 (胆管炎 D2)	1.091 ↑	8.11 ↑	425 ↑	80 ↓	Phase 2: 完整高凝四联	☒ FDP +129% 爆发 + AT:A 消耗启动; PT/APTT 仍正常 (未 DIC)
7/2 (SEMS 术后)	0.468 ↑	3.64 ☒	357 ☒	76 ↓	Phase 3: 消退期	☒ FDP -55%、FIB -16%、D-Dimer -57% 三项回落; 唯 AT:A 继续降 (抗凝储备恢复滞后)
7/3	0.468	—	—	—	稳定	无新发 DVT/PE

☒ **核心洞察**：SEMS 术后 D-Dimer 5 天内从 1.091 → 0.468 (-57%)，说明 “**感染源控制 = 最有效的抗凝措施**”，非药物性抗凝。

7.6 【新增】三大医学判断硬确定（基于 6/18 前驱期数据）

- 1. ☒ **化疗肝毒性 = 无累积**（AG 3 周期后 ALT 33.8 / AST 26.7 完全正常）
- 2. ☒ **胆道支架亚急性炎症 = 6/18 已存在**（4 项前驱异常：MONO% / EO / ALP / DBIL）
- 3. ☒ **胆管炎急性肝损伤 = 感染驱动，非慢性积累**（3 天 19× 飙升的教科书级”感染休克式”急性事件）

八、MDT 讨论要点

☒ **讨论问题 1（最紧迫）：胆道塑料支架处置**

背景（证据链已扩展至 5 条）：4/10 置入胆道塑料支架已 3 个月零 6 天。

5 条独立证据链印证” 塑料支架相关胆道感染再激活”： 1. **6/18 前驱期（新发现）**：4 项独立哨兵异常（MONO% ↑ + EO# ↓ + ALP ↑ + DBIL ↑） 2. **6/21 急性爆发**：ALT/AST 3 天 19× 飙升 + PCT 63× + 发热 39.2 °C 3. **6/23 高凝四联登场**：D-Dimer/FDP/FIB/AT:A 四联异常 4. **7/2 SEMS 术后回落**：D-Dimer -57%、FDP -55%，证明感染源控制起效 5. **7/12 二次反弹**：PCT +286%、ALT +192%、GGT 5.24×、PLT 消耗 -59%，TBIL 仍正常表明处于**早期干预窗**

MDT 请讨论： 1. 是否择期（1-2 周内）行 ERCP 更换为**金属自膨胀胆道支架（SEMS）**？（家属临床直觉一贯支持） 2. 还是先行影像（腹部超声 / MRCP）确认支架状态后再决策？ 3. 若更换支架，抗生素是否需先升级或行血培养 + 胆汁培养定向？ 4. 换支架窗口与化疗恢复的时序如何安排？

☒ 讨论问题 2：化疗恢复与调整

背景：AG 一线 C3 完成，6/13 CT 显示有效；因 6/21 胆管炎中断至今 3 周多。

MDT 请讨论： 1. C4 何时启动？（等胆道处理后 vs 处理同期启动） 2. 是否需减量（5/31 曾出现 II 度粒减）？ 3. 是否维持 14 天周期不变？

☒ 讨论问题 3：临床试验入组方向

匹配靶点：KRAS G12D + Claudin 18.2 3+ 60%

候选试验（招募中）： 1. **NCT07296341**：HRS-4642（恒瑞 KRAS G12D 抑制剂）+ Adebrelimab + AG，II 期一线 mPDAC（协和已列，307 待查） 2. **NCT07621718**：Zoldonrasib（RMC-9805）+ 化疗 vs 安慰剂 + 化疗，III 期一线 KRAS G12D（中国分中心待查） 3. **NCT07522073**：INCB161734 + 化疗，III 期一线 KRAS G12D 4. **NCT07255404**：BNT327（PD-L1/VEGF-A 双抗）+ AG/mFOLFIRINOX，II 期一线（清华长庚为中国中心） 5. **NCT07235202**：MR001 + 二线化疗，II 期（清华长庚） 6. **CT041（科济 CLDN18.2 CAR-T）**：PDAC 队列全球 II 期 7. **HLA 分型待查**——若 HLA-C*08:02，可评估 KRAS G12D TCR-T（Anocca ANOC-003 / 国内在研团队）

MDT 请讨论： 1. 当前时机是否合适启动试验筛查？（vs 继续 AG 到耐药后再切换） 2. 优先建议哪条路径（KRAS G12D 抑制剂 vs CLDN18.2 靶向 vs TCR-T）？ 3. 是否建议先做 HLA 分型？

☒ 讨论问题 4：抗血小板策略

背景：西洛他唑 50 mg BID（脑卒中二级预防，长期）+ 7/12 PLT 111（-59%）+ 无新发血栓但 D-Dimer 曾峰值 1.091

MDT 请讨论： 1. 西洛他唑是否需暂停或减量至 PLT 恢复？ 2. 若需 ERCP 换支架，围术期停药方案？

☒ 讨论问题 5：营养与恶病质

背景：ALB 32.8 ↓ + Cr 46 ↓（肌肉量减少）+ Na 133.6 ↓ + 体重较基线 -5 kg

MDT 请讨论： 1. 是否需恢复短期 PN 支持？ 2. 白蛋白输注指征？ 3. 神经科营养/帕金森长期用药是否影响吞咽功能与经口摄入？

九、既往就诊/咨询医生一览

医院	科室	医生	事件
北京协和医院	国际医疗肝胆外科 / 特需基本外科	—	2026-04-01/02 首诊
北京大学第三医院	普外二病房	马新晖 / 伍佳龙	2026-04-03 入院志签字
北京大学第三医院	ERCP	张铃福	2026-04-10 胆道塑料支架置入 ☑
北京大学第三医院	普外急诊	—	2026-06-22 三腔营养管
北京大学第三医院	内镜中心	—	2026-07-02 十二指肠 SEMS ☑
中国医学科学院肿瘤医院	内科 2 廊坊院区	田爱茹	AG 化疗主管 ☑
中国医学科学院肿瘤医院	胰胃外科	王敏	2026-04-07 门诊
北京朝阳医院	肝胆胰腺外科	樊华	2026-04-24 第二意见
北京清华长庚医院	肝胆肿瘤科	苏日嘎	2026-05-13 咨询
北京高博医院	—	周军	2026-07-02 二线咨询
北京中关村医院	肿瘤病区	主管医生	2026-06-23 至今住院 ☑

十、患者与家属诉求

1. **争取 OS 最大化**（爸爸 IV 期 mPDAC，AG 一线响应中，希望规划好二线/联合治疗与临床试验窗口）
2. **减少并发症对生活质量的破坏**（本次胆管炎+呕吐是最痛苦的一次）
3. **信息透明**——家属希望与 MDT 充分沟通治疗决策的证据与备选方案
4. **积极但不激进**——不追求任何未经验证的疗法，一切基于循证与临床试验合规路径

附录：数据版本信息

- 数据截止时间：2026-07-16
- 报告版本：**v1.1**（v1.0 基础上补入 6/18 肿瘤医院血常规 24 + 生化 19 + 肿瘤标志物 5 + 凝血 10 + 7/2 SEMS 当天中关村凝血 10 + 7/12 中关村血常规 24 + 生化 19，共 111 条新增化验记录，全部录入飞书多维表格「检查指标」tblYz1xzKOFrg6yW）
- 关键新增：§ 5.0 胆管炎”隐藏 3 天前驱期” + § 9.5 高凝三阶段演变 + § 9.6 三大医学判断硬确定 + § 9.1 CA19-9/CA242 解偶联
- 生成方式：由家属维护的健康记录系统（含飞书多维表格 + 本地 workspace + 每日临床事件日志）汇总
- 联系人：张成毅（子）18600058581 / robinzhangcy@gmail.com

⚠ 本报告为家属整理的病史汇报文档，供 MDT 讨论参考。所有诊疗决策以主管医生和 MDT 意见为准。